

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

# Сыпь у беременных

Дифференциальная диагностика зудящих дерматозов беременности:  
от безобидных до неотложных

---

Физиологические и патологические дерматозы беременности, дифференциальная  
диагностика с инфекционными сыпями.

Один вызов: зудящая сыпь на животе у беременной 33 недель с единственным эпизодом  
лихорадки.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 28 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

### Сыпь у беременной

“Беременная, 27 лет, первая беременность, срок 33 недели. На животе сыпь, мелкие красные пятна, не возвышаются над кожей. При диаскопии элементы вроде бы бледнеют, но они и так не яркие, как-то сомнительно. Сыпь зудит, пациентка отмечает усиление зуда в вечернее время. Сыпи нет на других участках тела, на конечностях, спине, лице. На животе — растяжки (striae gravidarum). Слизистые без изменений. Было однократное повышение температуры до 38 °С. Спала сама, без жаропонижающих.

При осмотре пациентка активная, самочувствие удовлетворительное. Температура 36,8 °С, АД 118/75 мм рт. ст., ЧСС 88 в минуту, ЧД 16 в минуту, SpO<sub>2</sub> 99 %. Окружность живота и высота стояния дна матки соответствуют сроку беременности, живот мягкий, безболезненный. Шевеления плода чувствуются, сердцебиение плода 140 в минуту.

Акушерской патологии вроде нет, в инфекционном плане не уверен, но подъём температуры зафиксирован, поэтому ехать ей в инфекционку.

В итоге пациентка категорически отказывается от госпитализации в инфекционный стационар и остается дома.”

### Вопросы для размышления

---

Ответы — в конце материала.

1. Какой первый вопрос относительно сыпи, который нужно задать до начала дифференциальной диагностики?
2. Почему сыпь на животе у беременной требует особого внимания и какие состояния нужно исключить в первую очередь?
3. PUPPP (Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy) — что это, каковы типичные сроки возникновения, локализация и прогноз?
4. Пемфигиоид беременных (pemphigoid gestationis) — чем отличается от PUPPP, какие опасности для матери и плода?
5. Псориаз при беременности — как изменяется течение болезни, какие особенности локализации и чем отличается от других дерматозов?
6. Внутрипечёночный холестаз беременных — почему это включается в дифференциальный диагноз при зуде без видимой сыпи?
7. Как инфекционные сыпи отличить от дерматозов беременности на догоспитальном этапе?
8. Что делать при отказе от госпитализации и какие критерии требуют обязательной госпитализации?

### Общие положения

---

Дерматозы беременности встречаются у 20–40 % беременных и варьируют от физиологических изменений до состояний, угрожающих жизни матери и плода. Большинство дерматозов беременности специфичны для гестационного периода и патогенетически связаны с гормональными и иммунологическими изменениями.

Ключевое различие в дифференциальной диагностике — разграничение зудящих дерматозов беременности и инфекционных сыпей. Зудящие дерматозы беременности характеризуются преимущественной локализацией на животе, отсутствием системных признаков инфекции и закономерными сроками возникновения. Инфекционные сыпи

при беременности требуют немедленной оценки и исключения в связи с потенциальным риском для плода (ветряная оспа, краснуха, другие вирусные экзантемы).

Задача догоспитального этапа заключается не в постановке точного нозологического диагноза дерматоза, а в исключении инфекционной природы сыпи и оценке риска для матери и плода.

## Классификация дерматозов беременности

### Физиологические изменения

- **Гиперпигментация** — потемнение ареол, linea nigra, мелазма (хлоазма)
- **Striae gravidarum** (растяжки) — типичны для III триместра, локализуются на животе, бёдрах, груди
- **Васкулярные изменения** — паутинные ангиомы, пальмарная эритема
- **Увеличение сальных и потовых желёз** — может усиливать акне

Эти изменения не требуют лечения и не влияют на исход беременности.

### Специфические дерматозы беременности

| Дерматоз                                   | Срок возникновения                     | Локализация                                      | Характер сыпи                    | Зуд         | Прогноз                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>PUPPP (полиморфная сыпь беременных)</b> | III триместр, чаще primigravida        | Живот, особенно в области растяжек               | Уртикарии, папулы, бляшки        | Есть        | Благоприятный, проходит после родов                  |
| <b>Пемфигоид беременных</b>                | II–III триместр, может начаться раньше | Живот, распространяется на всё тело              | Пузыри, везикулы, эритема        | Сильный     | Риск для плода, требует наблюдения                   |
| <b>Внутрипечёночный холестаз</b>           | III триместр                           | Нет сыпи или слабо выраженные эксфолиации        | Обычно нет сыпи                  | Сильный зуд | Риск для плода, требует лечения                      |
| <b>Псориаз</b>                             | Любой триместр (может обостряться)     | Локти, колени, волосистая часть головы, поясница | Эритематозные бляшки с чешуйками | Может быть  | Обычно благоприятный, тяжёлые формы — риск для плода |
| <b>Атопическая сыпь беременных</b>         | Любой триместр                         | Любая локализация                                | Экземоподобная сыпь              | Есть        | Благоприятный                                        |

## Основные дерматозы беременности

### PUPPP — полиморфная сыпь беременных (Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy)

Наиболее частый специфический дерматоз беременности; распространённость составляет 1 : 150–300 беременных.

- **Срок возникновения:** III триместр, преимущественно у primigravida (первая беременность); возможно начало в раннем послеродовом периоде
- **Локализация:** дебют в области растяжек передней брюшной стенки с последующим распространением на бёдра, ягодицы, реже — на верхние конечности; лицо и слизистые оболочки, как правило, не поражаются
- **Морфология элементов:** уртикарии, папулы, бляшки; элементы склонны к слиянию, что может создавать картину, сходную с крапивницей; везикулы и пузыри не характерны (их наличие указывает на пемфигоид беременных)
- **Зуд:** выраженный, усиливается в вечернее и ночное время
- **Системные проявления:** отсутствуют; общее состояние беременной не страдает
- **Прогноз:** благоприятный; спонтанное разрешение в течение 1–2 недель после родов; рецидивы при последующих беременностях редки



PUPPP: характерная сыпь в области растяжек на животе; уртикарии и папулы, сливающиеся в бляшки.

**Дифференциальная диагностика:** отличие от крапивницы — постоянная локализация на животе, длительное существование элементов, ассоциация с беременностью. Отличие от пемфигоида беременных — отсутствие пузырей, начало в III триместре, благоприятный прогноз.

**Лечение:** местные кортикостероиды, антигистаминные препараты для облегчения зуда. Системные кортикостероиды не требуются. Госпитализация не нужна при удовлетворительном состоянии матери и плода.



PUPPP: распространённая сыпь на животе и бёдрах; характерное расположение в области растяжек.

### Пемфигоид беременных — Pemphigoid gestationis

Редкий аутоиммунный буллёзный дерматоз; распространённость — 1 : 50 000 беременных.

- **Срок возникновения:** преимущественно II триместр; возможен дебют в I триместре или раннем послеродовом периоде
- **Локализация:** начало в периаумбиликальной области с последующим распространением на весь живот, затем — на конечности, ладонные и подошвенные поверхности; возможно поражение лица и слизистых оболочек
- **Морфология элементов:** эритема, уртикарии, папулы с последующим формированием пузырей и везикул; элементы имеют тенденцию к группировке
- **Зуд:** интенсивный, часто предшествует появлению сыпи
- **Системные проявления:** возможны слабость, недомогание
- **Прогноз:** риск для плода включает преждевременные роды и гипотрофию; для матери характерны обострения при последующих беременностях; сыпь может персистировать или обостряться в первые месяцы после родов



Пемфигоид беременных: пузыри и везикулы на эритематозном фоне; характерная локализация вокруг пупка.

**Дифференциальная диагностика:** отличие от PUPPP — наличие пузырей, более раннее начало, риск для плода. Отличие от других буллёзных дерматозов — связь с беременностью, наличие специфических антител.

**Лечение:** системные кортикостероиды (преднизолон), наблюдение акушером-гинекологом, возможная госпитализация для контроля состояния плода. Местное лечение недостаточно.



Пемфигоид беременных: распространённая сыпь с пузырями на животе и конечностях; характерное начало вокруг пупка.

### Внутрипечёночный холестаз беременных

Состояние, не являющееся дерматозом в строгом смысле, но имеющее важное значение в дифференциальной диагностике зуда при беременности.

- **Срок возникновения:** III триместр
- **Локализация:** сыпь обычно отсутствует; при выраженном зуде возможны эксориации вследствие расчёсывания
- **Клиническая картина:** изолированный зуд без видимой сыпи, усиливающийся в ночное время; возможна желтуха
- **Лабораторные изменения:** повышение уровня желчных кислот, трансаминаз, билирубина
- **Прогноз:** риск для плода включает преждевременные роды и внутриутробную гибель; требуется лечение урсодезоксихолевой кислотой, возможно раннее родоразрешение

**Дифференциальная диагностика:** отсутствие сыпи при сильном зуде, повышение печёночных проб, связь с беременностью.

### Псориаз при беременности

Псориаз — хроническое воспалительное заболевание кожи; течение при беременности вариабельно. По данным литературы, у 40–60 % женщин отмечается улучшение кожных

проявлений во время беременности, у 10-20 % — обострение, у остальных — стабильное течение.

- **Срок возникновения:** обострения возможны в любом триместре
- **Локализация:** классические локализации включают локтевые и коленные суставы, волосистую часть головы, поясничную область; возможна генерализация процесса
- **Морфология элементов:** эритематозные бляшки с серебристыми чешуйками; характерна псориазная триада (стеариновое пятно, терминальная плёнка, точечное кровотечение)
- **Зуд:** варьируется — от отсутствия до выраженного
- **Прогноз:** для плода, как правило, благоприятный; тяжёлые формы ассоциированы с повышенным риском преждевременных родов и низкой массы тела плода при рождении



Псориаз при беременности: характерные бляшки с серебристыми чешуйками на классических локализациях.

**Дифференциальная диагностика:** отличие от PUPPP — отсутствие связи с растяжками, наличие чешуек, классические локализации (локти, колени). Отличие от пемфигоида беременных — отсутствие пузырей, хроническое течение до беременности.

**Лечение:** местные кортикостероиды, эмоленды, при тяжёлых формах — системные препараты (циклоспорин, биологические препараты) по строгим показаниям и под наблюдением специалиста. Требуется консультация дерматолога.

## Инфекционные сыпи при беременности

Несмотря на то, что большинство сыпей у беременных — это дерматозы, инфекционную природу нужно исключить в первую очередь.

## Краснуха

- **Сыпь:** пятнисто-папулёзная, начинается на лице, распространяется вниз
- **Сопутствующие признаки:** лихорадка, лимфаденопатия (затылочные узлы), конъюнктивит
- **Риск для плода:** высокий в I триместре — врождённые пороки развития
- **Дифференциальная диагностика:** эпидемиологический анамнез, контакт с больными, отсутствие вакцинации



Краснуха: пятнисто-папулёзная сыпь на лице и туловище; характерная лимфаденопатия. Изображение: CDC Public Health Image Library (public domain).

## Ветряная оспа

- **Сыпь:** везикулёзная, «пёстрая» — пятна, папулы, везикулы, корки одновременно
- **Сопутствующие признаки:** лихорадка, недомогание
- **Риск для плода:** высок риск в I и II триместрах — врождённая ветряная оспа, риск пневмонии у матери
- **Дифференциальная диагностика:** характерная сыпь, контакт с больным, отсутствие вакцинации



## Коклюш

- **Сыпь:** может быть мелкая пятнистая сыпь, но не обязательный признак
- **Сопутствующие признаки:** приступообразный кашель, рвота после кашля
- **Риск для матери и плода:** у матери — осложнения дыхательных путей; для плода — риск преждевременных родов
- **Дифференциальная диагностика:** характерный кашель, эпидемиологический анамнез

## Алгоритм догоспитального обследования

### Осмотр и сбор анамнеза

1. **Первый вопрос:** когда появилась сыпь, как прогрессировала, что предшествовало появлению
2. **Локализация:** тщательно осмотреть всё тело, включая слизистые
3. **Характер сыпи:** диаскопия, морфология элементов, динамика
4. **Сопутствующие симптомы:** лихорадка, кашель, насморк, боль в горле, артралгии, общее состояние
5. **Акушерский анамнез:** срок беременности, течение беременности, движения плода
6. **Эпидемиологический анамнез:** контакты с инфекционными больными, поездки

### Ключевые отличия

| Признак                           | Дерматозы беременности                  | Инфекционные сыпи                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Лихорадка</b>                  | Редко, если есть — обычно субфебрильная | Характерна, нередко высокая                     |
| <b>Системные признаки</b>         | Отсутствуют или минимальны              | Присутствуют (кашель, насморк, слабость)        |
| <b>Локализация</b>                | Часто ограничена (живот)                | Генерализованная                                |
| <b>Динамика</b>                   | Медленная, постоянная                   | Быстрая, прогрессирующая                        |
| <b>Эпидемиологический анамнез</b> | Отрицательный                           | Часто положительный                             |
| <b>Диаскопия</b>                  | Бледнеют (сосудистые)                   | Бледнеют (сосудистые) или нет (геморрагические) |

## Критерии госпитализации

Обязательная госпитализация требуется при:

1. **Подозрении на инфекционную природу сыпи** с лихорадкой и системными признаками
2. **Тяжёлом состоянии матери** — нарушение гемодинамики, дыхательная недостаточность
3. **Признаках поражения плода** — изменение сердцебиения, уменьшение движений
4. **Подозрении на пемфигоид беременных** — пузыри, быстрое распространение
5. **Подозрении на внутрипечёночный холестаз** — сильный зуд без сыпи, желтуха

## 6. **Отсутствии возможности наблюдения** — социальные показания

При отказе от госпитализации при удовлетворительном состоянии матери и плода, отсутствии признаков инфекции и характерной картине PUPPP — возможна динамическая оценка на месте с рекомендацией консультации дерматолога и акушера-гинеколога в женской консультации.

## Возвращение к клиническому случаю

### Сыпь у беременной

Диаскопия показала, что сыпь бледнеет — это сосудистая сыпь, а не геморрагическая. Уже это делает менингококковую инфекцию маловероятной, но инфекцию нужно исключить полностью.

**Локализация.** Сыпь ограничена животом — конкретно областью растяжек. Ни на конечностях, ни на спине, ни на лице элементов нет. Эта локализация характерна для PUPPP — самого частого специфического дерматоза беременности. Инфекционные сыпи обычно генерализованные.

**Характер сыпи.** Пятна и папулы, местами сливающиеся в бляшки — типичная картина PUPPP. Нет пузырей, что исключает пемфигоид беременных. Нет везикул, что исключает ветряную оспу. Элементы не возвышаются, как при крапивнице, и длительность их существования — несколько дней, а не часы.

**Зуд.** Сыпь зудит, что характерно для дерматозов беременности и сосудистых сыпей. При чисто геморрагических сыпях (петехии, пурпура инфекционной природы) зуд отсутствует.

**Сопутствующие признаки.** Лихорадка была однократная до 38 °C, сейчас температура нормальная. Нет катаральных явлений, нет кашля, насморка, боли в горле — это делает вирусную инфекцию маловероятной. Нет лимфаденопатии, что делает краснуху маловероятной. Нет признаков тяжёлого состояния — пациентка активная, гемодинамика стабильная.

**Срок беременности.** 33 недели — это III триместр, когда PUPPP возникает наиболее часто. Для пемфигоида беременных более характерно начало во II триместре. Для внутрипечёночного холестаза — III триместр, но обычно нет видимой сыпи, а есть сильный зуд и желтуха.

**Эпидемиологический анамнез.** Контакт с инфекционными больными отрицательный, поездок не было. Это делает инфекционную природу сыпи маловероятной.

Совокупность признаков — локализация на животе в области растяжек, зуд, сосудистый характер сыпи (бледнеет при диаскопии), отсутствие системных признаков инфекции, срок беременности — указывает на PUPPP. Инфекционная природа маловероятна, но требует исключения из-за риска для плода.

Догоспитальная тактика: полное обследование, диаскопия, сбор анамнеза. При удовлетворительном состоянии матери и плода, отсутствии признаков инфекции, характерной картине PUPPP — возможна динамическая оценка на месте с рекомендацией консультации дерматолога и акушера-гинеколога в женской консультации. При отказе от госпитализации — информировать о рисках, обеспечить возможность наблюдения.

## Ответы на вопросы

---

- 1.** Когда появилась сыпь? Время появления — ключевой фактор дифференциальной диагностики: оно позволяет соотнести сыпь с триместром беременности и отличить дерматозы беременности от инфекционных экзантем.
- 2.** Сыпь на животе у беременной требует исключения специфических дерматозов беременности (PUPPP, пемфигоид беременных) и инфекционных сыпей (краснуха, ветряная оспа). В первую очередь нужно исключить инфекцию из-за риска для плода.
- 3.** PUPPP — самый частый специфический дерматоз беременности, возникает в III триместре, чаще при первой беременности, локализуется на животе в области растяжек, проявляется уртикариями и папулами, зудит, имеет благоприятный прогноз, проходит после родов.
- 4.** Пемфигоид беременных — редкий аутоиммунный дерматоз, возникает во II–III триместрах, начинается вокруг пупка, характеризуется пузырями и везикулами, несёт риск для плода (преждевременные роды, гипотрофия), требует системных кортикостероидов и наблюдения.
- 5.** Псориаз при беременности может улучшаться у 40–60 % женщин, обостряться у 10–20 %. Характеризуется эритематозными бляшками с серебристыми чешуйками на классических локализациях (локти, колени, волосистая часть головы, поясница). Отличается от PUPPP отсутствием связи с растяжками и наличием чешуек, от пемфигоида беременных — отсутствием пузырей и хроническим течением до беременности.
- 6.** Внутрипечёночный холестаз беременных включается в дифференциальный диагноз при сильном зуде без видимой сыпи, может сопровождаться желтухой, несёт риск для плода, требует лечения урсодезоксихолевой кислотой и возможного раннего родоразрешения.
- 7.** Инфекционные сыпи отличают по наличию системных признаков (лихорадка, катаральные явления), эпидемиологическому анамнезу, быстрой динамике, генерализованной локализации. Дерматозы беременности — локализованные, без системных признаков, медленно прогрессирующие.
- 8.** При отказе от госпитализации необходимо оценить состояние матери и плода, исключить инфекцию, обеспечить возможность наблюдения. Обязательная госпитализация — при признаках инфекции, тяжёлом состоянии, подозрении на пемфигоид беременных или холестаз.

## Основные выводы

| № | Вывод                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Сыпь на животе у беременной — чаще PUPPP, но сначала исключить инфекцию. Лихорадка, системные признаки, эпидемиологический анамнез в пользу инфекции.                                                                                                                                       |
| 2 | PUPPP — III триместр, растяжки, уртикарии, зуд, благоприятный прогноз. Пемфигоид беременных — пузыри, риск для плода, требует кортикостероидов.                                                                                                                                             |
| 3 | Псориаз при беременности — может улучшаться или обостряться, бляшки с чешуйками на классических локализациях, обычно благоприятный для плода.                                                                                                                                               |
| 4 | Внутрипечёночный холестаз — зуд без сыпи, повышение печёночных проб, риск для плода, требует урсодезоксихолевой кислоты.                                                                                                                                                                    |
| 5 | Инфекционные сыпи исключают по анамнезу, системным признакам, динамике. Краснуха, ветряная оспа несут риск для плода.                                                                                                                                                                       |
| 6 | При подозрении на инфекционную природу сыпи, тяжёлом состоянии матери или признаках поражения плода — обязательная госпитализация. При благоприятной картине PUPPP и отказе от госпитализации — динамическая оценка на месте с рекомендацией консультации дерматолога и акушера-гинеколога. |